

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Elena Rosa Cardona Restrepo

DOCUMENTO

CC 41789456

FECHA NACIMIENTO

01/01/1945

EDAD

81 años, 5 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria Incompleta

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

19/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001249

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Grober

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Elena Rosa Cardona Restrepo	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 41789456	Ocupación:	Agricultora (jubilada)
Fecha de nacimiento:	01/01/1945	Ciudad:	Sonsón, Antioquia
Edad:	81 años, 5 meses	Acompañante:	Juan David Cardona Henao
Sexo:	Femenino	Remite:	Médico familiar
Escolaridad:	Primaria Incompleta	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Pérdida de memoria progresiva de 3 años. Desorientación temporal, repite historias, dificultad para cocinar y manejar dinero. No reconoce ocasionalmente a nietos. MMSE 22/30 en consulta previa.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Grober

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
ViDeno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavag	Socioemocional - Depresión	—
Mini-Mental State Examination (MMSE)	General	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC.

Traumáticos

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Familiares

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Memoria

Déficit severo en memoria episódica anterógrada. No retiene información tras distractores. Memoria remota parcialmente preservada (hechos antiguos).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Anomia moderada. Parafasias semánticas. Comprensión de órdenes complejas descendida. Fluidez muy descendida.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: G30.0 - Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano (leve)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

Escala de Depres

5

Normal

Mini-Mental Stat

21

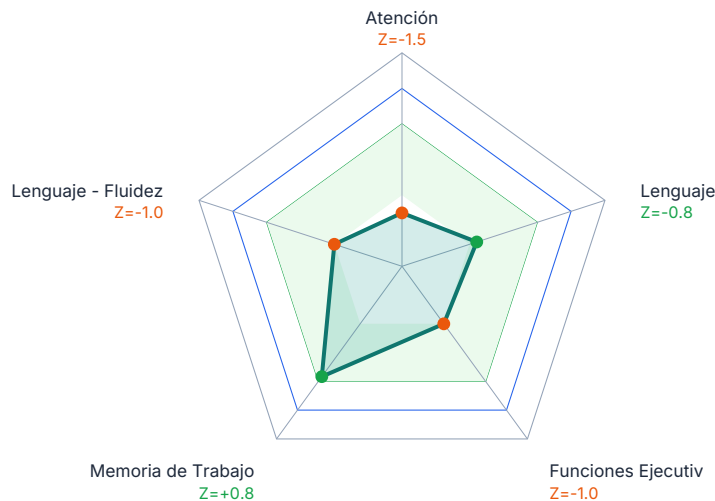
Deficit Leve

Escala de Lawton

4

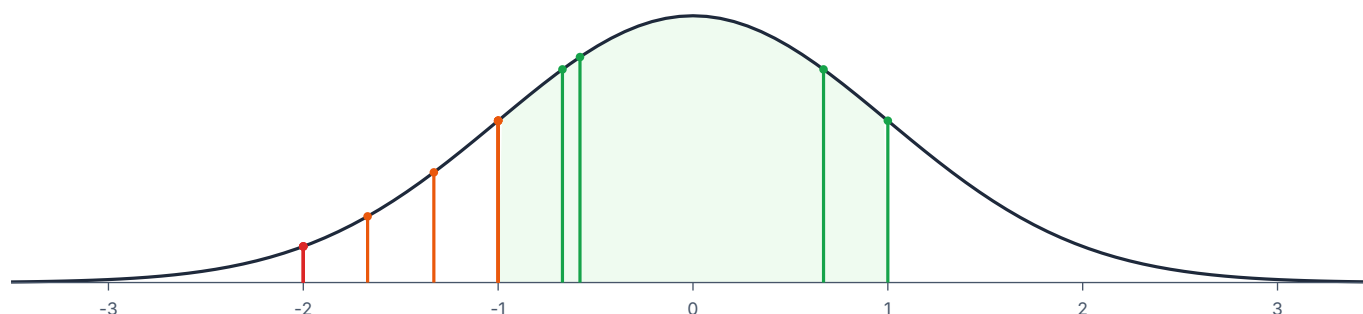
Deficit Extremo

Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 13 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-1.00
TMT B							-1.00
Span Retención Dígitos Directo							+1.00
Span Retención Dígitos Inverso							+0.67
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-1.67
Test de Stroop Palabra/Color							-1.33
Fluidez Verbal Animales							-1.00
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-1.00
ViDeno							-0.58
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.00
Grober RLT - Retención Libre Tot							-0.67
Grober RT - Recuerdo Total Clave							-2.00
Escala de Depresión Geriátrica Y							-6.33
Mini-Mental State Examination (M							-5.27
Escala de Lawton y Brody (IADL)							-6.40

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	182	7	-1.00	Promedio
TMT B	322	7	-1.00	Promedio
Span Retención Dígitos Directo	5	13	+1.00	Superior
Span Retención Dígitos Inverso	3	12	+0.67	Promedio
Test de Stroop Palabra	30	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	23	5	-1.67	Límitrofe
Test de Stroop Palabra/Color	9	6	-1.33	Límitrofe
Fluidez Verbal Animales	8	7	-1.00	Promedio
Fluidez Verbal Fonémica (P)	6	7	-1.00	Promedio
ViDeno	28	28	-0.58	Promedio
Grober RL Ensayo 1 (libre)	4	4	-2.00	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total	5	8	-0.67	Promedio
Grober RT - Recuerdo Total Claves	7	4	-2.00	Bajo
Escala de Depresión Geriátrica Yes	5	5	-6.33	Normal
Mini-Mental State Examination (MMS	21	21	-5.27	Deficit Leve
Escala de Lawton y Brody (IADL)	4	4	-6.40	Deficit Extremo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: general (moderadamente disminuido, $Z=-1.6$); atención (moderadamente disminuido, $Z=-1.5$); funciones ejecutivas (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$); lenguaje - fluidez (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Palabra ($Z=-2.00$, bajo); Grober RL Ensayo 1 (libre) ($Z=-2.00$, bajo); Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) ($Z=-2.00$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido / superior

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Color — límite ($Z=-1.67$)
- Test de Stroop Palabra/Color — límite ($Z=-1.33$)
- Fluidez Verbal Animales — promedio ($Z=-1.00$)
- Span Retención Dígitos Directo — superior ($Z=+1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Elena. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En ViTMTA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViTMTB, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViRDD, tu rendimiento fue muy por encima del promedio. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViGroberMC_Tot, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En ViTMTA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViTMTB, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViRDD, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViAni, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViGroberMC_Tot, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.